



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 19, 2026

ESTUDIO DE PSILOCIBINA Y METFI-TAE-CPEA EL PRIMER PASO: LA EXISTENCIA DE ESTADOS LATENTES RECUPERABLES MEDIANTE CAMBIOS DE ORGANIZACIÓN MÁS QUE MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN ANATÓMICA

"No constituye una validación directa de METFI-TAE-CPEA, pero sí podría considerarse una **observación compatible con algunas de sus hipótesis centrales**, especialmente si se reformulan de manera operacional y falsable".

Nivel 1. Lo que realmente demuestra el estudio

El trabajo de 2026 es un **caso clínico único** (n=1) de una paciente con Alzheimer avanzado que experimentó mejoras funcionales transitorias tras la administración de psilocibina. Los propios autores enfatizan que:

- No hubo reversión de la neurodegeneración.
- No puede establecerse causalidad.
- No existían biomarcadores ni EEG cuantitativo.
- No hubo neuroimagen funcional.
- El resultado debe considerarse generador de hipótesis.

Desde el punto de vista científico convencional, esto es evidencia de nivel muy bajo.

Nivel 2. Lo interesante para TAE

Donde sí veo una conexión fuerte es con la TAE.

La observación más llamativa no es que aparezca neuroplasticidad.

Lo llamativo es que aparecen capacidades consideradas "perdidas":

- lenguaje autobiográfico,
- memoria contextual,
- continencia,
- interacción social,
- planificación motora.

Y aparecen de forma relativamente rápida.

Eso abre una pregunta:

¿Estaban destruidas esas funciones o simplemente inaccesibles?

La interpretación clásica es:

- existe tejido residual,
- la psilocibina aumenta conectividad funcional,
- se accede temporalmente a redes parcialmente preservadas.

La interpretación TAE podría ser:

- el sistema cognitivo no había perdido completamente la información;
- había aumentado la entropía de acceso;
- una perturbación excepcional reorganizó temporalmente la arquitectura predictiva.

En otras palabras:

la excepción reorganiza el sistema.

Eso encaja sorprendentemente bien con la lógica de aprendizaje por excepción.

Nivel 3. Lo interesante para CPEA

Aquí aparece algo mucho más potente.

El estudio carece precisamente de la variable que tú llevas años proponiendo:

seguimiento EEG de coherencia predictiva antes y después del evento.

Imagina que hubieran registrado:

- EEG basal.
- EEG durante la fase aguda.
- EEG durante la recuperación funcional.

Entonces podrías contrastar una hipótesis CPEA:

El retorno de funciones cognitivas coincide con un aumento transitorio de coherencia predictiva global.

No estarías midiendo memoria.

No estarías midiendo lenguaje.

Estarías midiendo la estructura dinámica que hace posible ambas cosas.

Si apareciera:

- incremento de sincronización interregional,
- reducción de ruido predictivo,
- aumento de coherencia multiescala,

entonces CPEA ganaría muchísimo apoyo experimental.

Actualmente el estudio no permite evaluarlo porque esos datos no existen.

Nivel 4. Lo interesante para METFI

Aquí debemos ser más prudentes.

METFI introduce una hipótesis adicional:

Los sistemas biológicos están acoplados a dinámicas electromagnéticas toroidales multiescala.

El estudio no mide:

- geomagnetismo,
- actividad electromagnética ambiental,
- resonancias Schumann,
- variabilidad electromagnética local.

Por tanto:

no valida METFI directamente.

Sin embargo sí proporciona algo que METFI necesita:

La demostración observacional de que estados neurológicos aparentemente irreversibles pueden contener capacidad funcional latente.

Eso es compatible con una visión dinámica del cerebro como sistema metastable.

Compatible no significa validado.

Donde creo que está la verdadera oportunidad

Si yo tuviera que conectar seriamente este caso con METFI-TAE-CPEA diseñaría el siguiente experimento.

Grupo Alzheimer temprano

Registrar:

- EEG de alta densidad.
- HRV cardíaca.
- Magnetómetros ambientales.
- Variables geomagnéticas.
- Escalas cognitivas.

Antes y después de:

- psilocibina,
- ketamina,
- estimulación magnética,
- meditación profunda.

Hipótesis TAE:

Las mejoras aparecen cuando ocurre una excepción organizativa.

Hipótesis CPEA:

Las mejoras coinciden con un aumento cuantificable de coherencia predictiva.

Hipótesis METFI:

La coherencia predictiva se ve modulada por variables electromagnéticas multiescala.

Eso sí sería un programa experimental capaz de empezar a discriminar entre modelos.

Mi valoración

Diría que este caso:

- **No valida METFI.**
- **No valida TAE.**
- **No valida CPEA.**

Pero sí aporta un dato extremadamente interesante:

Funciones cognitivas aparentemente extinguidas pueden permanecer accesibles bajo determinadas reorganizaciones dinámicas del sistema nervioso.

Y precisamente esa idea, la existencia de estados latentes recuperables mediante cambios de organización más que mediante reconstrucción anatómica es probablemente el punto donde el caso clínico se acerca más a la arquitectura conceptual que llevas desarrollando desde 2021.

De hecho, si el estudio hubiese incorporado EEG longitudinal, podría haberse convertido en uno de los primeros casos candidatos para una prueba experimental preliminar de la hipótesis CPEA.

Autor conceptual: GPT(OpneAI) | **Director y originador:** Javi Ciborro

Serie: ICPC (Índice de Coherencia Predictiva Clínica) — Extensión EXC (Excepción)

Estado: Propuesta de protocolo experimental, no validado

Le he echado un vistazo al caso clínico y al análisis que adjuntas. Coincido con la valoración de fondo: es un n=1 sin EEG, sin biomarcadores, sin neuroimagen — generador de hipótesis, nada más. Pero el hueco de datos que señala (ausencia de seguimiento EEG longitudinal pre/post) es exactamente el tipo de laguna que un artículo del corpus puede convertir en una propuesta de protocolo falsable, que es donde el corpus ya tiene tracción (DEPD-VAL-1, CPEA-PFI-1, NEXUS-EEG).

Confirmado. El caso es real, está publicado en *Frontiers in Neuroscience* (Lago, Cerveira & Simonet, 2026, DOI 10.3389/fnins.2026.1813281), y los detalles que aporta el análisis de GPT son correctos: los hallazgos no implican reversión de la enfermedad pero sugieren que puede persistir capacidad funcional residual en neurodegeneración avanzada, accesible transitoriamente bajo condiciones neuromoduladoras específicas. Es un único paciente, observado en un entorno clínico privado real, sin neuroimagen, sin monitorización formal del sueño, sin evaluación cognitiva estandarizada. El timeline es llamativo: aproximadamente 19 horas después comenzó a hablar espontáneamente de forma autobiográfica, y una segunda dosis de 3 gramos un mes después se asoció con mayor expresividad verbal. [Frontiers + 2 ↗](#)

Mi valoración, antes de la decisión de formato:

El análisis de GPT está bien construido pero tiene un sesgo que conviene corregir. Trata el caso como "anécdota interesante que casi encaja" — y luego propone *otro* experimento ideal con magnetómetros, geomagnetismo, etc. Eso es expandir el alcance en vez de explotar lo que ya tenemos. El corpus no necesita un protocolo más ambicioso; necesita uno que sea ejecutable con el instrumental que NEXUS-EEG ya tiene operacional (.cpea_stream, pipeline en tiempo real).

Mi recomendación de encaje:

No es un DEP-D-VAL-2. DEP-D-VAL-1 funciona porque el Strange Face Effect es una excepción perceptual controlada, reproducible en laboratorio, en sustrato sano — exactamente el tipo de excepción para el que TAE-E1/E2 fueron diseñados. Aquí la excepción es farmacológica, en sustrato neurodegenerado, con un n=1 no controlado. Forzarlo en la misma serie metodológica diluye el rigor que distingue a DEP-D-VAL-1.

CPEA-ICPC-EXC-1: Reorganización transitoria post-excepción farmacológica en Neurodegeneración Avanzada — Protocolo de Seguimiento EEG-CPEA

Autor conceptual: Claude (Anthropic) | **Director y originador:** Javi Ciborro

Serie: ICPC (Índice de Coherencia Predictiva Clínica) — Extensión EXC (Excepción)

Estado: Propuesta de protocolo experimental, no validado

Resumen

Un caso clínico publicado en 2026 documenta mejoría funcional multidominio transitoria en una paciente con enfermedad de Alzheimer avanzada tras la administración de una dosis alta de psilocibina, incluyendo recuperación de habla autobiográfica, continencia, movilidad y reconocimiento contextual previamente ausentes durante años. El reporte original carece de toda instrumentación fisiológica cuantitativa: no hay EEG, no hay neuroimagen, no hay biomarcadores. Este artículo no presenta el caso como validación de ningún componente del Corpus Papayaykware. Lo utiliza como motivación empírica para formalizar un protocolo de seguimiento (*no* monitorización) EEG-CPEA aplicable a excepciones farmacológicas en sustrato neurodegenerado, ejecutable con la infraestructura NEXUS-EEG y el pipeline `.cpea_stream` ya operacionales. Se propone una quinta categoría dentro del marco ICPC — el perfil de **Reorganización Transitoria Inducida (RTI)** — definido por una firma dinámica específica en el Índice de Coherencia Predictiva Clínica, distinta de los cuatro perfiles clínicos basales ya formalizados. Se derivan predicciones falsables y se especifica el diseño experimental mínimo viable, incluyendo criterios de exclusión que mantienen el documento estrictamente en el plano de diseño de investigación, sin contenido de dosificación práctica.

Introducción: el problema que deja abierto el caso clínico

La enfermedad de Alzheimer avanzada se entiende convencionalmente como una fase de declive funcional irreversible, en la que el sustrato neuroanatómico necesario para ciertas funciones (lenguaje autobiográfico, memoria contextual, control esfinteriano voluntario) se considera destruido, no simplemente inaccesible. El caso de Lago, Cerveira y Simonet (2026) introduce una anomalía relevante para esta asunción: tras una dosis única de 5 g de psilocibina en hongos de la cepa Enigma, una paciente octogenaria con diez años de evolución de Alzheimer y cinco años de hipofunción marcada —habla monosilábica, incontinencia urinaria crónica, disfagia, movilidad dependiente, afecto plano— comenzó, aproximadamente 19 horas después de la administración, a hablar espontáneamente en términos autobiográficos. En los días siguientes la familia documentó mejoras en habla, memoria contextual, movilidad, conexión emocional y continencia. Una segunda dosis de 3 g un mes después se asoció a mayor expresividad verbal y agilidad.

Los propios autores son explícitos respecto a las limitaciones: es un caso único, observado en contexto clínico privado real, sin imagen cerebral, sin monitorización formal del sueño, sin evaluación cognitiva estandarizada, y sin capacidad de establecer causalidad. El estudio se presenta a sí mismo como generador de hipótesis.

Desde la perspectiva del Corpus Papayaykware, el valor del caso no reside en su fuerza probatoria — que es mínima— sino en la pregunta estructural que deja sin resolver: ¿la mejoría refleja la activación de tejido residual mediante un mecanismo puramente neuroquímico de conectividad aumentada, o refleja una reorganización dinámica del régimen predictivo del sistema, en el sentido formalizado

por TAE-F1/TAE-F2? Esta pregunta no es respondible con los datos publicados, porque la variable que la discriminaría —coherencia predictiva EEG seguida longitudinalmente antes, durante y después del evento— no fue registrada. Ese es exactamente el vacío que este documento formaliza como protocolo.

Por qué esto no es DEPD-VAL-2

Es necesario señalar explícitamente por qué este caso no se incorpora a la serie DEPD-VAL, y se trata en cambio como extensión de ICPC.

DEPD-VAL-1 valida el protocolo de detección de excepciones (TAE-E1/E2) contra el paradigma Strange Face Effect: una excepción perceptual, controlada, reproducible en laboratorio, inducida en sustrato cognitivo sano. Las condiciones de control —línea base estable, manipulación experimental discreta, ausencia de confusores farmacológicos o patológicos— son las que permiten que esa serie funcione como validación metodológica estricta del detector de excepciones.

El caso aquí discutido tiene una estructura distinta en tres aspectos:

1. **Sustrato:** no es un cerebro sano con una perturbación perceptual puntual, sino un sistema con neurodegeneración avanzada y una intervención farmacológica de efectos sistémicos amplios (autónómicos, térmicos, de arquitectura del sueño).
2. **Controlabilidad:** $n=1$, sin grupo control, sin aleatorización, con múltiples variables de confusión no registradas (expectativa familiar, contexto, fluctuación natural de la demencia avanzada, que puede incluir episodios de lucidez paradójica documentados independientemente en la literatura geriátrica).
3. **Tipo de excepción:** es una excepción inducida farmacológicamente sobre un sistema cuyo régimen predictivo basal ya está patológicamente alterado, no una excepción perceptual sobre un régimen predictivo sano.

Mezclar esto con DEPD-VAL diluiría el rigor metodológico que distingue esa serie. En cambio, encaja naturalmente como extensión de ICPC, que ya está diseñado para operar sobre sustratos clínicos heterogéneos y para definir perfiles de coherencia predictiva en condiciones patológicas.

El perfil de Reorganización Transitoria Inducida (RTI) dentro de ICPC

El marco ICPC define el Índice de Coherencia Predictiva Clínica mediante tres subíndices — δ (desviación), ρ (recuperación), π (persistencia)— que en conjunto caracterizan cuatro perfiles clínicos basales. Este documento propone una quinta categoría, no como sustituto de los perfiles existentes sino como clase dinámica ortogonal a ellos: el perfil de **Reorganización Transitoria Inducida**.

Definición operacional

Un perfil RTI se caracteriza por:

- Una **desviación aguda** (δ) de gran magnitud y corta duración, coincidente con la fase autonómica aguda post-administración (hipertermia clínicamente sospechada, sudoración profusa, estado de sueño profundo prolongado en el caso de referencia).

- Una **fase de recuperación** (ρ) que no retorna al baseline patológico previo, sino que estabiliza transitoriamente en un régimen funcional intermedio, de mejor desempeño que el baseline pero sin alcanzar parámetros normativos.
- Un **índice de persistencia** (π) cuya caída temporal define la ventana de la excepción — en el caso de referencia, del orden de semanas, con una segunda excepción (segunda dosis) capaz de reabrir o extender la ventana.

A diferencia de los cuatro perfiles ICPC basales, que describen estados relativamente estacionarios de la dinámica predictiva clínica, el perfil RTI es intrínsecamente transitorio por definición: su variable de interés no es el valor de ICPC en un punto, sino la **forma de la trayectoria** ICPC(t) alrededor del evento de excepción.

Hipótesis CPEA central

H-RTI-I: El retorno transitorio de funciones cognitivas y motoras consideradas perdidas en neurodegeneración avanzada coincide temporalmente con un incremento medible de coherencia predictiva global (CPEA), no únicamente con conectividad funcional aumentada de forma inespecífica.

Esta hipótesis es deliberadamente más restrictiva que la interpretación neuroquímica convencional (aumento de conectividad funcional vía agonismo 5-HT_{2A}). No la contradice — son compatibles — pero exige una variable adicional: que el aumento de conectividad esté organizado de forma coherente respecto al modelo predictivo previo del sistema, no que sea ruido de banda ancha aumentado. Esta es la distinción que el diseño experimental de la sección 5 debe poder discriminar.

Relación con TAE

El perfil RTI es, en el lenguaje de TAE-F1, la traza clínica de una excepción de orden superior actuando sobre un sistema cuyo orden parámetro Ψ ya estaba degradado por la enfermedad de base. TAE-F2 describe la dinámica post-excepción en términos de transiciones de primer y segundo orden y mecanismo de Kibble-Zurek; el caso de referencia, con su patrón de mejoría progresiva durante días y semanas más que un salto discreto inmediato, es compatible a priori con una dinámica de relajación post-excepción de tipo continuo, pero esto es una predicción a contrastar, no un hecho establecido por el caso publicado.

Lo que el caso no permite afirmar, y por qué importa decirlo aquí

Siguiendo la convención de falsabilidad explícita del corpus, conviene enumerar con la misma precisión lo que este documento **no** sostiene:

- No sostiene que la psilocibina revierta neurodegeneración.
- No sostiene que el caso valide TAE, CPEA o METFI.
- No sostiene que la mejoría observada sea atribuible a coherencia predictiva aumentada — esa es la hipótesis a contrastar, no una conclusión.
- No extrapola a recomendación clínica ni a pauta de administración alguna.

- No descarta la hipótesis convencional (conectividad funcional inespecífica vía agonismo serotoninérgico) como explicación suficiente; el protocolo de la sección 5 está diseñado específicamente para poder discriminar entre ambas, no para confirmar la hipótesis CPEA por defecto.

Protocolo experimental propuesto

Principio de diseño: ejecutable con infraestructura existente

A diferencia de la propuesta de ampliar instrumentación (magnetómetros ambientales, variables geomagnéticas) sugerida como extensión hacia METFI, este protocolo se restringe deliberadamente a lo que NEXUS-EEG v1.0 y el pipeline `.cpea_stream` ya soportan en producción, de modo que sea ejecutable sin desarrollo de hardware adicional. La extensión hacia variables geomagnéticas (acoplamiento METFI) se señala en la sección 7 como fase posterior, no como requisito de entrada.

Población y diseño

- **Diseño:** serie de casos prospectiva, no un ensayo controlado aleatorizado en esta fase inicial — dado el contexto regulatorio y ético de intervenciones con psilocibina en pacientes con demencia avanzada, que requiere marco institucional propio fuera del alcance de este documento.
- **Criterio de inclusión:** pacientes ya enrolados en programas clínicos autorizados de investigación con psilocibina en neurodegeneración (existen ensayos registrados en curso a nivel internacional para depresión y demencia). Este protocolo se diseña como **módulo de seguimiento EEG añadible** a esos ensayos ya autorizados, no como ensayo independiente que administre la sustancia.
- **Tamaño muestral mínimo:** $n \geq 8$ para una estimación preliminar de varianza en la trayectoria ICPC(t), consistente con el estándar de series de casos piloto en neuromodulación.

Variables y temporalidad de registro

Fase	Momento	Instrumento	Variable CPEA
Baseline	7 días antes	NEXUS-EEG, <code>.cpea_stream</code>	ICPC(t_0), δ - ρ - π basales
Pre-evento inmediato	1 hora antes	NEXUS-EEG	Confirmación de estabilidad de ICPC
Fase aguda	0–24h post	NEXUS-EEG continuo	δ agudo, latencia de pico
Fase de recuperación	día 1–7	NEXUS-EEG, sesiones diarias	ρ , forma de la curva de relajación
Fase de persistencia	semana 2–8	NEXUS-EEG, sesiones semanales	π , tiempo de decaimiento
Re-excepción (si aplica)	tras segunda dosis	NEXUS-EEG	Comparación de amplitud δ entre primer y segundo evento

En paralelo, evaluación cognitiva/funcional estandarizada (no especificada aquí en detalle por no ser objeto del corpus técnico) en los mismos puntos temporales, para poder correlacionar ICPC(t) con desempeño funcional observado y así contrastar H-RTI-1 frente a la hipótesis nula de mejoría sin correlato de coherencia.

Análisis discriminante propuesto

La pregunta central —¿coherencia organizada o conectividad inespecífica aumentada?— se opera mediante dos métricas ya formalizadas en el corpus:

- **CPEA(t)** como índice de coherencia predictiva propiamente dicho (estructura organizada).
- Una métrica de control de **conectividad funcional cruda** (por ejemplo, coherencia espectral de banda ancha sin ponderación por estructura predictiva), que debería aumentar bajo la hipótesis convencional independientemente de si hay o no organización predictiva.

Predicción discriminante (falsable): si H-RTI-1 es correcta, el aumento de CPEA(t) debería preceder o ser proporcionalmente mayor que el aumento de conectividad cruda durante la ventana de mejoría funcional. Si la hipótesis convencional es suficiente, ambas métricas deberían moverse de forma indistinguible, sin disociación temporal ni de magnitud.

Riesgos de sobreinterpretación y mitigación

Dado que este es exactamente el tipo de caso que invita a sobreajustar el marco teórico a un solo dato anecdótico, se establecen explícitamente los criterios de invalidación:

- Si en la serie propuesta ($n \geq 8$) la trayectoria CPEA(t) no muestra un patrón consistente de δ - ρ - π reconocible —es decir, si la respuesta es heterogénea sin estructura común— el perfil RTI como categoría unificada queda invalidado, y el fenómeno debería tratarse caso por caso sin pretensión de generalización.
- Si la disociación predicha entre CPEA(t) y conectividad cruda no aparece, H-RTI-1 queda falsada en favor de la hipótesis convencional, y el documento debe revisarse o retirarse del corpus.
- Ningún resultado de este protocolo, aun siendo positivo, constituye evidencia sobre METFI (acoplamiento electromagnético multiescala); esa es una extensión separada y posterior, no implícita en este diseño.

Extensión futura (fuera de alcance de este documento)

Una fase posterior, condicionada a resultados positivos en la fase EEG-CPEA aquí descrita, podría incorporar variables geomagnéticas ambientales (I_{bio} , METFI-F2) para contrastar si la ventana de persistencia π se modula por variables electromagnéticas multiescala. Esto requeriría la instrumentación adicional que el análisis externo proponía, pero se señala aquí como **fase 2 condicional**, no como parte del diseño mínimo viable de fase 1.

Resumen

- El caso Lago et al. (2026, *Frontiers in Neuroscience*) es un n=1 sin EEG, sin neuroimagen, sin biomarcadores: generador de hipótesis, no validación de nada.
- No se incorpora a la serie DEPD-VAL por diferencias estructurales: sustrato neurodegenerado vs. sano, n=1 no controlado vs. paradigma reproducible, excepción farmacológica sistémica vs. perceptual discreta.
- Se propone una quinta categoría dentro de ICPC: el perfil de **Reorganización Transitoria Inducida (RTI)**, definido por la forma de la trayectoria ICPC(t) — δ agudo, ρ de recuperación parcial, π de persistencia— alrededor de una excepción farmacológica.
- Hipótesis central (H-RTI-1): la mejoría funcional coincide con coherencia predictiva organizada, no solo con conectividad funcional inespecífica aumentada — predicción diseñada para ser falsable y discriminable de la explicación convencional.
- El protocolo propuesto es ejecutable con la infraestructura NEXUS-EEG/.cpea_stream ya operacional, como módulo de seguimiento añadible a ensayos clínicos con psilocibina ya autorizados — no como ensayo independiente que administre la sustancia.
- Se especifican criterios explícitos de invalidación del perfil RTI y de falsación de H-RTI-1.
- La extensión hacia variables electromagnéticas (METFI) se señala como fase 2 condicional, fuera del alcance del diseño mínimo viable aquí descrito.
- El documento no incluye guía de dosificación ni recomendación clínica en ningún punto.

Referencias

- **Lago, M., Cerveira, M., & Simonet, J.X. (2026).** Transient multidomain functional improvement in advanced Alzheimer's disease following high-dose psilocybin-containing mushroom administration: a case report. *Frontiers in Neuroscience*, 20:1813281. — Caso clínico fuente; n=1, sin instrumentación fisiológica cuantitativa, generador de hipótesis según los propios autores.
- **Zheng, S., Ma, R., Yang, Y., & Li, G. (2024).** Psilocybin for the treatment of Alzheimer's disease. *Frontiers in Neuroscience*, 18:1420601. — Revisión previa del mecanismo propuesto (agonismo 5-HT_{2A}, neuroplasticidad en modelos preclínicos); contexto mecanístico convencional frente al cual se contrasta H-RTI-1.

Este documento es un paso hacia un protocolo de validación posible, no hacia una validación en sí. La diferencia no es semántica menor. Lo que hemos construido es la condición de falsabilidad que el caso original no tenía: si se ejecuta la serie de casos descrita y la trayectoria CPEA(t) no muestra el patrón δ - ρ - π , el perfil RTI cae. Eso es lo que lo hace valioso no que apunte hacia donde el corpus quiere ir, sino que pueda apuntar en contra.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota: Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate